



PROCEDIMENTO PADRÃO Nº 008

PROCESSO DE ALTA DO PACIENTE

FÁBIO COELHO



SUMÁRIO

1	PROCESSO DE ALTA DO PACIENTE	3
1.1	OBJETIVO GERAL	3
1.2	DEFINIÇÃO OPERACIONAL	3
1.2.1	ETAPAS DO PROCESSO DE ALTA	3
1.2.2	<i>CHECKLIST</i> DE CONFORMIDADE: PROCESSO DE ALTA	5
1.2.3	PADRONIZAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS PROFISSIONAIS	6
1.3	MODELO DE RELATÓRIO DE DEVOLUTIVA DE ALTA CLÍNICA	6
	REFERÊNCIAS	10



1 PROCESSO DE ALTA DO PACIENTE

1.1 OBJETIVO GERAL

Fornecer um modelo prático, baseado em evidências e boas práticas de gestão, para padronizar o processo de alta de aprendizes, garantindo alinhamento clínico, organização institucional e clareza para equipe e família.

1.2 DEFINIÇÃO OPERACIONAL

Alta clínica é o conjunto de ações organizadas e documentadas, executadas em equipe multiprofissional, que sinalizam o encerramento planejado da intervenção terapêutica, fundamentado no alcance dos objetivos individualizados.

1.2.1 ETAPAS DO PROCESSO DE ALTA

O processo de alta do(a) aprendiz segue um fluxo organizado de etapas, que visam garantir alinhamento entre clínica, equipe e família, promovendo segurança e clareza em todo o percurso. Abaixo estão listadas as etapas, os comportamentos esperados, os responsáveis, os produtos gerados e os pontos de verificação:

1. Realização da reavaliação final com base nos objetivos atingidos.
 - **Responsável:** Terapeuta responsável.
 - **Evidência:** Relatório de reavaliação.
 - **Ponto de verificação:** Documento registrado em prontuário.
2. Comunicação formal à equipe envolvida sobre o início do processo de alta.
 - **Responsável:** Terapeutas e supervisores de área.
 - **Evidência:** Comunicação formal (e-mail ou sistema).
 - **Ponto de verificação:** Registro arquivado da comunicação.



3. Registro no relatório ou na devolutiva de equipe do início da alta, com justificativas e objetivos alcançados.
 - **Responsável:** Terapeutas envolvidos.
 - **Evidência:** Relatório ou devolutiva atualizada, incluindo justificativas, previsão de alta e plano de redução gradual das terapias.
 - **Ponto de verificação:** Documento assinado.
4. Envio do relatório para revisão do(s) supervisor(es) de área.
 - **Responsável:** Terapeuta(s).
 - **Evidência:** Relatório encaminhado para análise.
 - **Ponto de verificação:** Feedback registrado pelo supervisor de área.
5. Submissão do relatório final ao supervisor geral para aprovação.
 - **Responsável:** Terapeuta.
 - **Evidência:** Relatório aprovado pelo RT, autorizando a entrega à família na data prevista para alta.
 - **Ponto de verificação:** Documento protocolado.
6. Comunicação ao supervisor de área, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, para solicitação do certificado.
 - **Responsável:** Terapeuta.
 - **Evidência:** Comunicação registrada e solicitação do certificado.
 - **Ponto de verificação:** Registro da data e planejamento.
7. Emissão do certificado de alta e providência de lembrança simbólica para entrega.
 - **Responsável:** Supervisor de área.
 - **Evidência:** Certificado e lembrança.
 - **Ponto de verificação:** Material preparado antes da última sessão.
8. Condução da entrevista de alta, com entrega de documentos à família e do certificado ao(à) aprendiz, recomendando reavaliação após 6 (seis) meses.
 - **Responsável:** Terapeuta.
 - **Evidência:** Assinatura de recebimento ou ata da entrevista.
 - **Ponto de verificação:** Registro da entrevista e devolutiva.



1.2.2 **CHECKLIST DE CONFORMIDADE DO PROCESSO DE ALTA**

O *checklist* de conformidade do processo de alta tem como objetivo garantir que todas as etapas previstas no fluxo de alta sejam devidamente cumpridas, assegurando a qualidade do atendimento, o alinhamento da equipe e a formalização adequada junto à família.

Legenda:

R = Realizado

N/A = Não se aplica

ITEM	R	N/A
Reavaliação final realizada com base nos objetivos do Plano de Desenvolvimento Individualizado (PDI)	☐	☐
Registro do início do processo de alta no relatório	☐	☐
Comunicação formal realizada com a equipe terapêutica e os supervisores de área	☐	☐
Aprovação final do relatório clínico de alta pela supervisão geral	☐	☐
Certificado e lembrança preparados	☐	☐
Entrevista final realizada, com entrega dos documentos à família pelo terapeuta	☐	☐
Proposta de reavaliação futura registrada (para daqui a seis meses)	☐	☐

Observações:



1.2.3 PADRONIZAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS PROFISSIONAIS

TERAPEUTA

- **Comportamento esperado:**
Sinalização de paciente elegível à alta com base em reavaliação técnica.
- **Responsável:**
Terapeuta.
- **Métrica de avaliação:**
Registro no relatório de equipe.
- **Frequência:**
Sempre que aplicável.

SUPERVISOR DE ÁREA

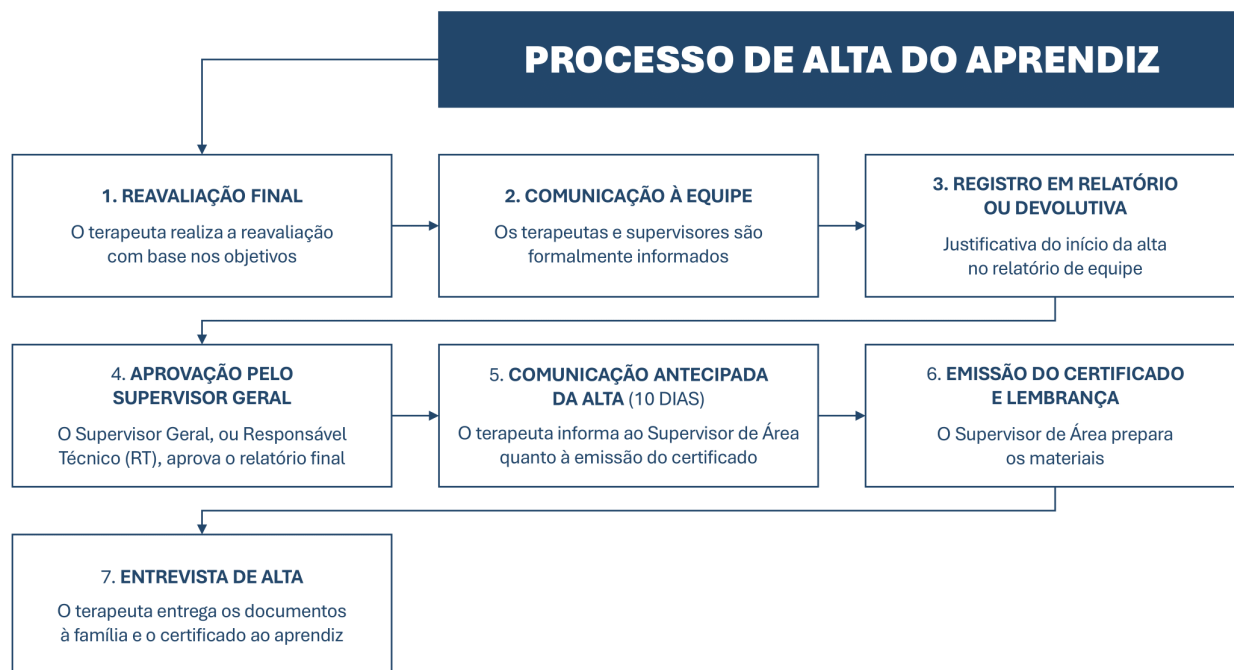
- **Comportamento esperado:**
Realização de revisão crítica do relatório de alta.
- **Responsável:**
Supervisor(a) de área.
- **Métrica de avaliação:**
Tempo de resposta $\leq 72h$.
- **Frequência:**
Sempre que solicitado.

SUPERVISOR GERAL

- **Comportamento esperado:**
Garantia da entrega do certificado antes da última sessão.
- **Responsável:**
Supervisor(a) geral.
- **Métrica de avaliação:**
100% dos casos.
- **Frequência:**
Contínuo.



1.2.4 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE ALTA: MODELO VISUAL



1.3 MODELO DE RELATÓRIO DE DEVOLUTIVA DE ALTA CLÍNICA

[NOME DA CLÍNICA]

RELATÓRIO DE ALTA: DEVOLUTIVA FINAL À FAMÍLIA

1. Identificação do aprendiz

- Nome completo.
- Data de nascimento.
- Diagnóstico.
- CID.
- Data de início do atendimento na clínica.
- Data da reavaliação final.
- Equipe envolvida na intervenção.
 - Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia.



2. Objetivo do relatório

Apresentar os resultados da reavaliação final, fundamentada nos objetivos estabelecidos no PDI, justificando a alta clínica do aprendiz e orientando sobre a continuidade do desenvolvimento e possíveis acompanhamentos futuros.

3. Síntese da intervenção realizada

Durante o atendimento, foram implementadas estratégias baseadas na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), com foco em:

- Aquisição de habilidades.
- Comunicação e linguagem.
- Comportamentos socialmente relevantes.
- Redução de comportamentos interferentes.
- Promoção de autonomia nas Atividades de Vida Diária (AVDs).
- Apoio familiar e generalização para outros contextos (escolar e social).
- Outros aspectos específicos.

4. Resultados da reavaliação final

A reavaliação foi realizada por meio de instrumentos padronizados (exemplo: VB-MAPP, ABLA-R e o Inventário Portage Operacionalizado), observações clínicas diretas e reuniões de equipe. Exemplo de apresentação dos resultados:

Dimensão avaliada	Objetivos do PDI	Nível inicial	Nível atual	Status
Comunicação	Solicitar itens e responder perguntas	30%	90%	Atingido
Habilidades sociais	Iniciar e manter interações sociais	20%	80%	Atingido
Comportamentos interferentes	Redução de crises de oposição	Alta frequência	Baixa frequência	Atingido
AVDs	Vestir-se de forma independente	Dependente	Independente	Atingido
Participação em atividades de grupo	Permanecer em roda por 10 minutos	1 minuto	10 minutos	Atingido



5. Justificativa para alta clínica

Após análise conjunta da equipe multidisciplinar, concluiu-se que:

- Os objetivos do PDI foram atingidos.
- Os comportamentos-problema foram reduzidos a níveis manejáveis no ambiente familiar e escolar.
- As habilidades foram generalizadas para outros ambientes e diferentes mediadores.
- Os responsáveis estão aptos a dar continuidade ao suporte, seja de forma autônoma ou com suporte pontual.

A alta clínica é, portanto, indicada com base em critérios técnicos, visando o bem-estar e os direitos do aprendiz.

6. Recomendações pós-alta

- Manter rotina estruturada em casa e na escola.
- Participação em atividades comunitárias (esporte, música, grupos sociais).
- Acompanhamento eventual com psicopedagogo ou psicólogo escolar, se necessário.
- Realizar reavaliação após seis meses, para monitoramento do desenvolvimento.

7. Considerações finais

A equipe técnica agradece à família pela parceria durante o processo terapêutico. Resaltamos que o desenvolvimento é contínuo e a autonomia conquistada reflete o esforço conjunto entre o aprendiz, a família e a equipe clínica. Mantemo-nos disponíveis para futuras orientações.

8. Assinaturas

[Espaço reservado para assinaturas]



REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA E MEDICINA COMPORTAMENTAL. **Registro para prestadores de serviço em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) ao desenvolvimento atípico/TEA da ABPMC**. ABPMC, 2019. Disponível em: <https://abpmc.org.br/wp-content/uploads/2021/11/1556901447d2fb7c4f8e55.pdf>. Acesso em: 07 maio 2025.



EQUIPE EDITORIAL

AUTORIA

Fábio Coelho

DIAGRAMAÇÃO E DESIGN GRÁFICO

Victor Cardoso

EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTO

Victor Cardoso

REVISÃO TÉCNICA

Càrol Lèal

CONSULTORES E ESPECIALISTAS

Fábio Coelho

Jenifer Macedo

Maria Christina Souza

PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO

Academia do Autismo

REDES SOCIAIS



@maaisacademiadoautismo



@maaisacademiadoautismo



@academiadoautismo



@academiadoautismo

CONTATO



maais@academiadoautismo.com.br



(22) 99216-0282



academiadoautismo.com.br/maais

Este material é protegido por direitos autorais e não pode ser comercializado, distribuído, copiado, editado, alugado, transmitido ou reproduzido, total ou parcialmente, em qualquer meio de comunicação ou distribuição. Permissões para tais ações podem ser concedidas somente mediante autorização expressa do detentor e proprietário dos direitos do material. Qualquer violação dos direitos autorais estará sujeita a ações legais. Todos os direitos estão reservados à Academia do Autismo Ltda.